किडनीचा आजार (CKD): रिपोर्ट समजून घ्या, काळजी कशी घ्यावी?

> किडनीचा त्रास असेल तर रिपोर्टमधले आकडे काय सांगतात, रक्तदाबाची काळजी कशी घ्यायची आणि रक्ताची कमतरता कधी तपासायची—हे सोप्या भाषेत समजून घेण्यासाठी हा लेख आहे. डॉक्टरांशी बोलताना उपयोगी पडतील असे मुद्देही यात दिले आहेत.

१. CKD म्हणजे नेमके काय?

किडनीचे काम किंवा तिच्या रचनेत झालेला बिघाड किमान ३ महिने टिकून असेल, तर त्याला दीर्घकालीन किडनीचा आजार (CKD) म्हणतात. एकदाच creatinine वाढले किंवा eGFR कमी आले म्हणून लगेच CKD ठरत नाही. ताप, उलट्या, जुलाब, शरीरात पाणी कमी होणे किंवा काही औषधांमुळेही रिपोर्ट तात्पुरता बदलू शकतो. म्हणून डॉक्टरांच्या सल्ल्याने पुन्हा तपासणी करून हा बदल कायमचा आहे का ते पाहतात.

२. रिपोर्ट पाहताना तीन गोष्टी लक्षात ठेवा

किडनीचा आजार कशामुळे झाला, किडनी किती काम करते (eGFR) आणि लघवीतून किती प्रथिने बाहेर जातात (urine ACR)—या तीन गोष्टी एकत्र पाहिल्या जातात. यालाच CGA वर्गीकरण म्हणतात. eGFR चांगला दिसत असला तरी लघवीत प्रथिने जात असतील, तर किडनीचा आजार असू शकतो.

३. eGFR आणि albuminuria categories

G1: ≥90; G2: 60–89; G3a: 45–59; G3b: 30–44; G4: 15–29; G5: <15 mL/min/1.73 m². Urine ACR: A1 <30 mg/g; A2 30–300 mg/g; A3 >300 mg/g. ACR शक्यतो spot urine (विशेषतः first-morning sample) मध्ये मोजा; abnormal result ची पुनर्तपासणी/संदर्भानुसार पुष्टी करा. KDIGO heat-map मध्ये GFR कमी आणि albuminuria जास्त होत गेल्यास जोखीम वाढते.

४. रक्तदाब योग्य पद्धतीने मोजणे महत्त्वाचे

रक्तदाब मोजण्यापूर्वी काही मिनिटे शांत बसा. हाताला योग्य आकाराचा cuff लावून, पाठ टेकवून आणि पाय जमिनीवर ठेवून मोजमाप करावे. KDIGO मधील 120 पेक्षा कमी या लक्ष्याचा अर्थ कुठेही घेतलेला कोणताही BP reading असा नाही. हे लक्ष्य ठरावीक प्रमाणित पद्धतीने घेतलेल्या मोजमापासाठी आहे. घरी BP नोंदवून डॉक्टरांना दाखवणेही उपयोगी ठरते.

५. CKD असेल तर रक्तदाब किती ठेवावा?

Dialysis सुरू नसलेल्या बहुतेक प्रौढ रुग्णांत, उपचार सहन होत असतील तर, प्रमाणित पद्धतीने मोजलेला वरचा रक्तदाब 120 mmHg पेक्षा कमी ठेवण्याचा KDIGO 2021 चा सल्ला आहे. पण उभे राहिल्यावर चक्कर येणे, BP खूप कमी होणे किंवा इतर आजार असतील तर लक्ष्य बदलावे लागू शकते. लघवीत प्रथिने जास्त असतील तर डॉक्टर ACE inhibitor किंवा ARB गटातील औषध देऊ शकतात. ही औषधे स्वतःहून सुरू किंवा बंद करू नका.

६. ACEi/ARB औषधे घेताना कोणत्या तपासण्या कराव्यात?

ही औषधे सुरू केल्यानंतर किंवा मात्रा वाढवल्यानंतर साधारण २–४ आठवड्यांनी BP, creatinine आणि potassium तपासणे गरजेचे असते. Creatinine ३०% पेक्षा जास्त वाढल्यास त्यामागचे कारण शोधावे. Potassium वाढला किंवा BP मुळे त्रास झाला तर डॉक्टर उपचारात बदल करू शकतात. रिपोर्ट बदलला म्हणून औषध अचानक बंद करण्याऐवजी डॉक्टरांशी संपर्क साधा.

७. मीठ, खाणे-पिणे आणि हालचाल

उच्च रक्तदाब आणि CKD असल्यास दिवसाचे मीठ साधारण ५ ग्रॅमपेक्षा कमी ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो. मात्र काही रुग्णांत मीठ कमी करणे योग्य नसेल—म्हणून स्वतःहून कडक आहार सुरू करू नका. Potassium असलेले low-sodium salt काही किडनी रुग्णांसाठी धोकादायक ठरू शकते. तब्येत आणि ताकद पाहून नियमित चालणे किंवा हलका व्यायाम करा. शक्य असल्यास आठवड्याला एकूण १५० मिनिटांचे मध्यम स्वरूपाचे चालणे/व्यायाम हे उद्दिष्ट ठेवता येते.

८. किडनीच्या आजारात रक्ताची कमतरता (ॲनिमिया)

CKD असलेल्या व्यक्तींमध्ये हिमोग्लोबिन कमी होऊ शकते. थकवा, अशक्तपणा किंवा दम लागणे अशी लक्षणे असतील तर डॉक्टरांना सांगा. तपासण्यांमध्ये CBC, reticulocyte count, ferritin आणि TSAT यांचा समावेश होतो. KDIGO 2026 नुसार साधारण तपासणीचे अंतर: G3 मध्ये वर्षातून एकदा, G4 मध्ये वर्षातून दोनदा आणि G5 किंवा dialysis मध्ये दर तीन महिन्यांनी. लक्षणे किंवा रक्तस्राव असल्यास आधी तपासणी लागू शकते.

९. Iron deficiency आणि iron therapy — thresholds

KDIGO 2026: Hemodialysis (CKD G5HD) मध्ये anemia असल्यास ferritin ≤500 ng/mL आणि TSAT ≤30% असल्यास iron therapy सुरू करण्याचा विचार (2D); सुरुवातीला IV iron ला oral पेक्षा प्राधान्य सुचविले आहे. Dialysis नसलेल्या CKD किंवा peritoneal dialysis मध्ये iron विचारात घ्या: ferritin <100 आणि TSAT <40%, किंवा ferritin 100 ते <300 आणि TSAT <25%. Hemodialysis नसताना oral किंवा IV मार्ग रुग्णाची पसंती, anemia/iron deficiency ची तीव्रता, सहनशीलता, उपलब्धता व खर्च यानुसार ठरतो. Routine iron थांबवण्याचा विचार ferritin >700 किंवा TSAT ≥40% असल्यास. हे treatment thresholds आहेत; isolated lab result वर स्वतःहून iron देऊ नका.

१०. Iron monitoring, ESA आणि transfusion निर्णय

Iron घेत असताना Hb, ferritin, TSAT: non-dialysis/PD मध्ये साधारण दर ३ महिन्यांनी; HD मध्ये दर १–३ महिन्यांनी. Optimal oral iron नंतर १–३ महिन्यांत परिणाम अपुरा किंवा सहन न झाल्यास IV iron विचारात घ्या; systemic infection मध्ये iron तात्पुरते थांबवण्याचा विचार. ESA/HIF-PHI पूर्वी iron deficiency, रक्तस्राव, infection/inflammation, B12/folate deficiency, thyroid/PTH आणि इतर reversible causes तपासा. Correctable causes सुधारल्यानंतर ESA हे HIF-PHI पेक्षा first-line सुचविले आहे (2D). Adult CKD रुग्णांत ESA चालू असताना Hb target <11.5 g/dL ठेवा. Dialysis वर ESA सुरू करण्याचा विचार Hb at or below 9–10 g/dL येथे; non-dialysis मध्ये लक्षणे व transfusion/ESA जोखीम वैयक्तिकरीत्या तोला. RBC transfusion चा निर्णय Hb आकड्यावरच नव्हे तर लक्षणे, urgency आणि clinical context वर घ्या.

११. क्लिनिकल safety points

NSAIDs, contrast, antibiotics व इतर औषधांचा renal function नुसार विचार करा; औषधांचा dose eGFR नुसार समायोजित करावा. Potassium, volume status, BP, creatinine/eGFR आणि albuminuria यांचे trend पाहा. अचानक oliguria, वेगाने वाढणारी सूज/दम, chest pain, syncope, गंभीर hyperkalemia संशय किंवा uremic complication असल्यास तातडीची clinical assessment आवश्यक. हा लेख dialysis prescription, transplant किंवा pediatric CKD साठी स्वतंत्र protocol नाही.

जीवाला धोका असलेल्या स्थितीत भारतात ११२ वर संपर्क करा. इतर देशांत स्थानिक आपत्कालीन क्रमांक वापरा.

१२. वापरासाठी झटपट checklist

☐ CKD chronicity ≥3 months पुष्टी? ☐ Cause + G category + A category नोंदवली? ☐ eGFR आणि urine ACR trend उपलब्ध? ☐ BP standardized पद्धतीने मोजला? ☐ ACEi/ARB indication आणि potassium/creatinine monitoring ठरवले? ☐ CBC/reticulocyte/ferritin/TSAT schedule ठरवले? ☐ औषधांचे renal dose review? ☐ nephrology referral/urgent escalation ची गरज तपासली?

मनातले प्रश्न

eGFR 58 एकदाच आला म्हणजे CKD?

नाही. कालावधी, repeat eGFR, urine ACR आणि इतर kidney-damage markers तपासून chronicity निश्चित करा.

SBP <120 सर्व CKD रुग्णांसाठी बंधनकारक आहे का?

नाही. KDIGO 2021 चे लक्ष्य dialysis न घेणाऱ्या प्रौढांमध्ये standardized office BP आणि सहनशीलतेच्या अटीवर आहे. Non-standardized reading वर थेट लागू करू नये.

ACEi/ARB मुळे creatinine वाढले तर लगेच बंद करायचे?

नाही. सुरुवात/dose वाढीनंतर 2–4 आठवड्यांत तपासणी करा; ४ आठवड्यांत >30% वाढ झाल्यास कारण शोधा व clinical context नुसार निर्णय घ्या.

2026 anemia guideline म्हणजे संपूर्ण CKD guideline आहे का?

नाही. ती CKD मधील anemia च्या निदान, iron, ESA/HIF-PHI आणि transfusion व्यवस्थापनावर केंद्रित आहे.

लक्षात ठेवण्याची गोष्ट

CKD चे मूल्यांकन CGA ने करा; BP चे लक्ष्य फक्त standardized measurement वर लागू करा; RASi/iron/ESA उपचारांमध्ये potassium, creatinine, Hb आणि iron indices यांचे नियोजित monitoring अत्यावश्यक आहे.

आधार आणि मूळ संदर्भ

KDIGO 2024 — CKD Evaluation and Management guideline
https://kdigo.org/guidelines/ckd-evaluation-and-management/

KDIGO 2021 — Blood Pressure in CKD guideline
https://kdigo.org/guidelines/blood-pressure-in-ckd/

KDIGO 2026 — Anemia in CKD guideline
https://kdigo.org/guidelines/anemia-in-ckd/

Government of India — Emergency Response Support System 112
https://112.gov.in/about

ही माहिती समजून घेण्यासाठी आहे. वैयक्तिक उपचारासाठी आपल्या डॉक्टरांची योजना पाळा. औषधे स्वतः बदलू नका. संदर्भ तपासले: २४ ऑक्टोबर २०२६.

Website: https://home-visiting-icu-doctor.vercel.app/#wikiSection
Article: ckd-kdigo | mr